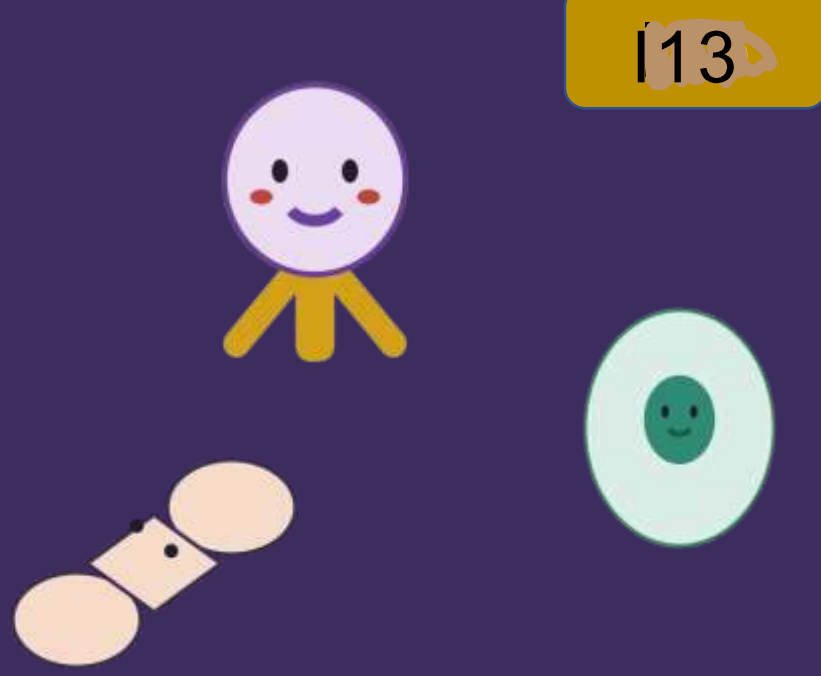


DISSOCIATION FR+ / ANTI-CCP– AVEC ANTI-SSA/RO60 À 400 AU/ML

Quand la sérologie démasque un Sjögren primaire purement articulaire, sans aucun signe clinique sicca

Ziane S. 1,2 · Merah F. 1,2 · Djidjik R. 1,2

1. Faculté de Pharmacie, Université des Sciences de la Santé · 2. Service d'Immunologie Médicale, CHU Béni Messous, Alger



1 Introduction

Face à une polyarthrite avec raideur matinale et facteur rhumatoïde (FR) positif, le réflexe diagnostique de polyarthrite rhumatoïde (PR) est quasi automatique. Or le FR n'est ni spécifique ni exclusif de la PR : environ 20 à 30% des PR authentiques sont FR+ mais anti-CCP négatif et cette dissociation s'observe aussi dans le lupus ou le syndrome de Sjögren, où elle doit élargir la réflexion diagnostique plutôt que la clore.

Le syndrome de Sjögren primaire (SSp) est une exocrinopathie auto-immune chronique dont la prévalence est estimée entre 0,01% et 0,05% en population générale, avec une très nette prédominance féminine (jusqu'à 14 femmes pour 1 homme) et un âge moyen au diagnostic entre 40 et 67 ans. L'anti-SSA/Ro60 en constitue le marqueur sérologique le plus spécifique, tandis que l'anti-CCP y reste rare , retrouvé chez moins de 10% des patients, et le plus souvent associé à une synovite non érosive plutôt qu'à une authentique PR associée (Atzeni et al., 2008).

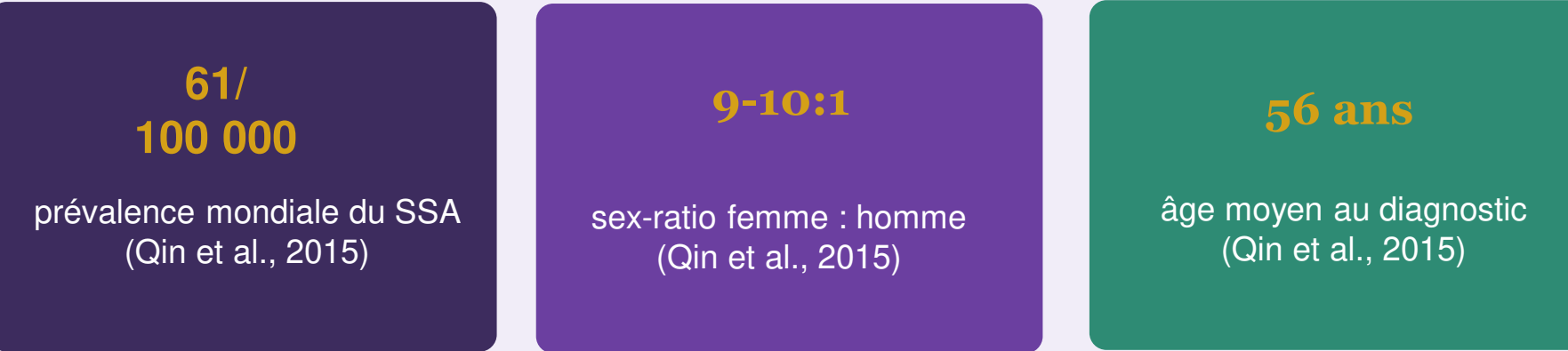
C'est précisément cette logique de dissociation sérologique FR positif, anti-CCP négatif, anti-SSA/Ro60 massivement positif qui a permis de redresser l'orientation clinique initiale dans le cas rapporté ici, alors même qu'aucun signe sicca n'était présent.

➤ PR authentique vs dissociation FR+/anti-CCP–

PR authentique : co-positivité FR/anti-CCP la règle ; l'anti-CCP est spécifique à 95% de la PR et précède souvent les érosions radiographiques.

Dissociation FR+/anti-CCP– : doit faire élargir le bilan (ENA, anti-SSA/Ro60, anti-SSB) avant de conclure à une PR séronégative . C'est parfois la seule fenêtre sérologique vers un diagnostic alternatif.

➤ Contexte épidémiologique



➤ Signes d'alerte à ne pas manquer

- FR positif mais anti-CCP négatif, surtout si le tableau articulaire semble « trop » typique.
- AAN positif à titre significatif chez une patiente étiquetée PR.
- Absence de signes sicca — elle n'élimine jamais un Sjögren primaire à expression systémique.
- Toute discordance sérologique doit élargir le bilan (ENA complet) avant de figer un diagnostic.

Ce que ce cas nous apprend : la biologie médicale peut redresser une orientation clinique établie ; à condition de laisser la sérologie parler, même quand la clinique semble sans appel.

5 Conclusion

Un Sjögren primaire peut se présenter sous une forme purement articulaire, capable de mimer une polyarthrite rhumatoïde au point de tromper l'orientation clinique initiale.

Dissociation FR+/anti-CCP– = signal d'alarme sérologique à ne jamais négliger devant une polyarthrite.

L'intensité de l'anti-SSA/Ro60 oriente à elle seule le diagnostic, même en l'absence totale de signes sicca.

Interdisciplinarité clinico-biologique — c'est l'analyse immunologique qui a redressé ce diagnostic, ouvrant la voie à un suivi ciblé.

2 Observation clinique

Femme de 40 ans, adressée au Service d'Immunologie Médicale du CHU Béni Messous par un interniste pour une polyarthralgie avec raideur matinale, rachialgies et amaigrissement — tableau clinique purement articulaire évoquant une PR, sans xérostomie, xérophtalmie ni autre signe extra-articulaire rapporté.

- Motif : Polyarthralgie + raideur matinale, type PR
- Signes associés : Rachialgies, amaigrissement
- Signes sicca : Absents (aucune xérostomie/xérophtalmie rapportée)
- Orientation initiale : Polyarthrite rhumatoïde suspectée → bilan immunologique demandé

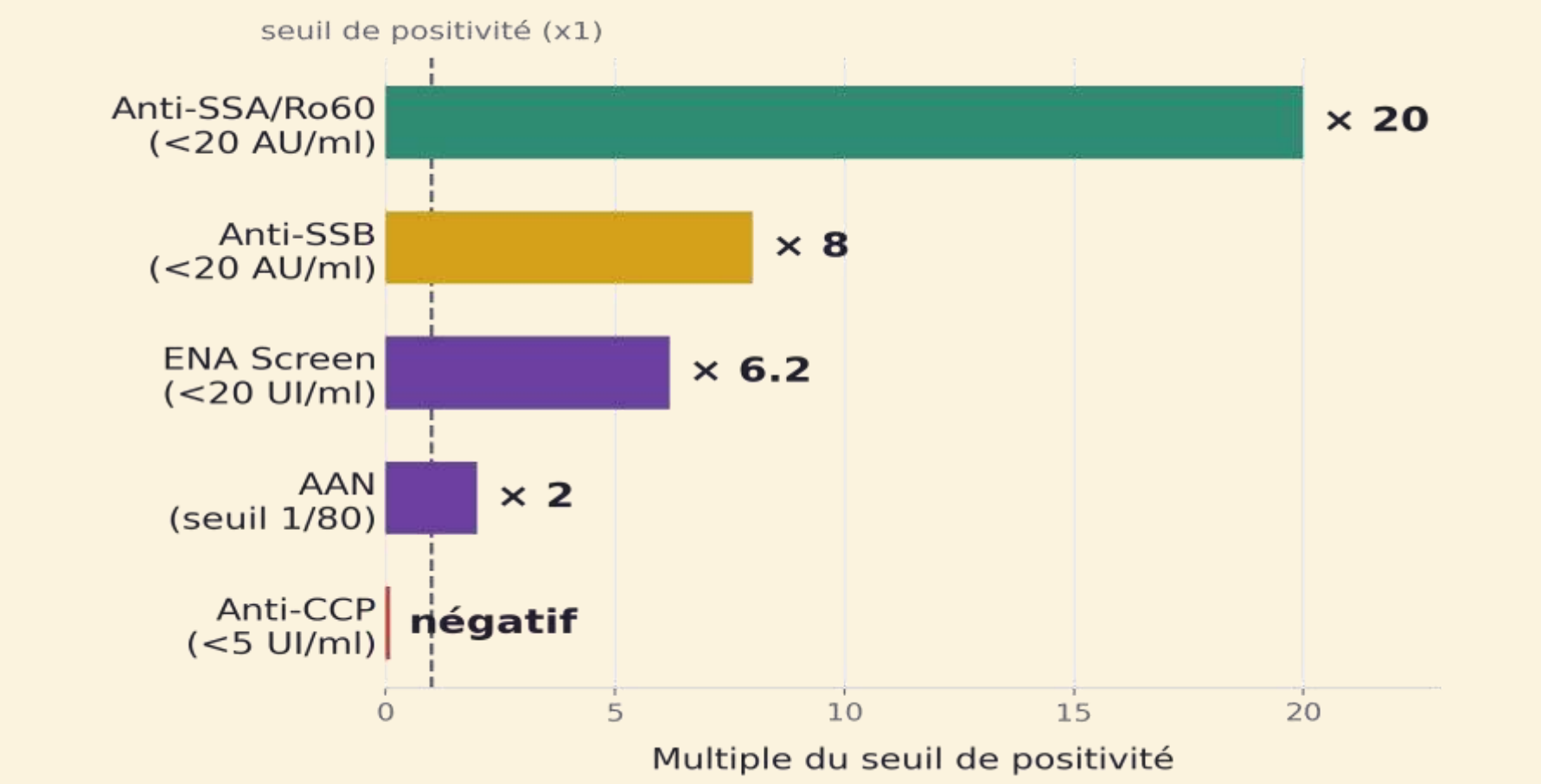


3 Résultats

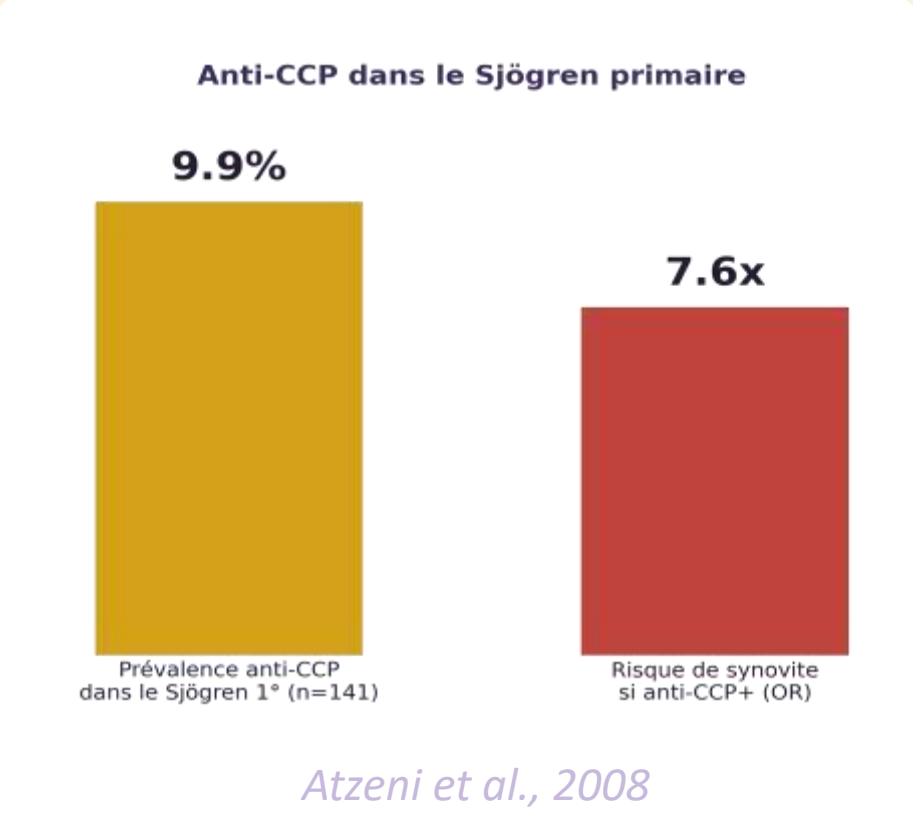
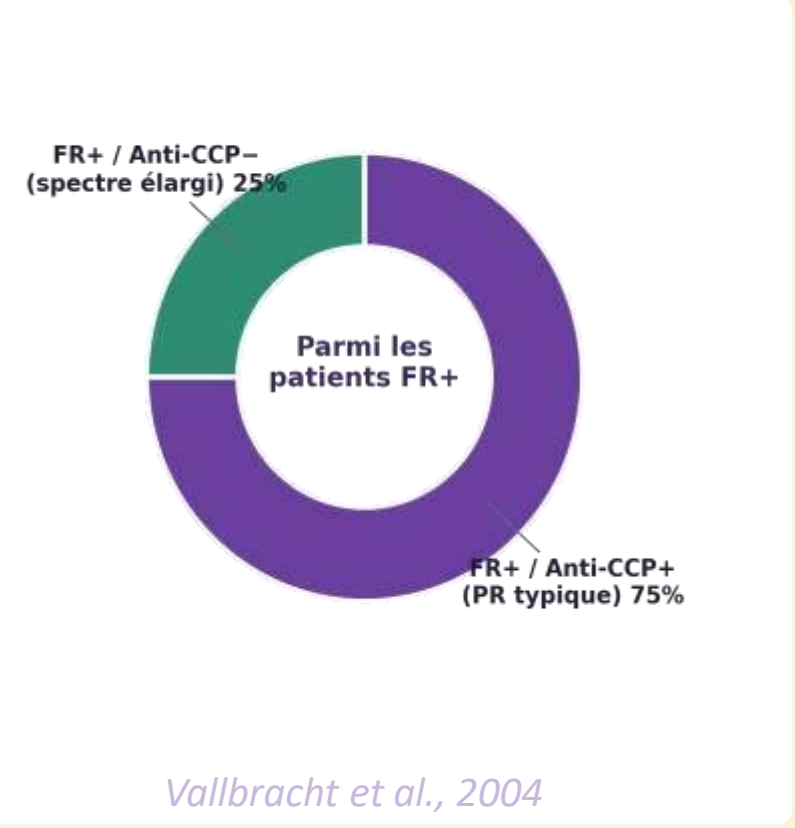
Bilan immunologique demandé : connectivites (FR, anti-CCP, AAN, ENA Screen, anti-SSA/Ro60, anti-SSB, anti-DNA, anti-Sm, anti-ScI70, anti-JO1).

Tableau clinique (évocateur PR)	FR+ (74,10 UI/ml)	Anti-CCP négatif	AAN+ / ENA+ SSA/Ro60 massif	Sco2016 = 3/4 pts re ACR/EULAR
---------------------------------	-------------------	------------------	-----------------------------	--------------------------------

Test	Résultat	Norme
FR	74,10 UI/ml	positif
Anti-CCP	< 0,5 UI/ml	< 5, négatif
AAN (HEp-2)	1/160 moucheté fin	< 1/80
ENA Screen	124 UI/ml	< 20
Anti-SSA/Ro60	400 AU/ml	< 20
Anti-SSB	160 AU/ml	< 20
Autres (DNA, Sm, ScI-70, JO-1)	négatifs	—



Synthèse : dissociation sérologique décisive — FR+ isolé, anti-CCP négatif, anti-SSA/Ro60 massivement positif (x20 le seuil). Score ACR/EULAR 2016 = 3 points en faveur d'un Sjögren primaire à expression exclusivement articulaire.



6 Références

1. Shiboski CH, et al. 2016 ACR/EULAR classification criteria for primary Sjögren's syndrome. Arthritis Rheumatol. 2017;69(1):35-45.
2. Bettacchioli E, et al. Association of combined anti-Ro52/TRIM21 and anti-Ro60/SSA antibodies with increased Sjögren disease severity through interferon pathway activation. Arthritis Rheumatol. 2024.
3. Armağan B, et al. Antibodies to both Ro52 and Ro60 for identifying Sjögren's syndrome patients best suited for clinical trials of disease-modifying therapies. Arthritis Care Res. 2022;74(10).
4. Serological stratification by anti-Ro52 and anti-Ro60 profiles reveals distinct systemic phenotypes in primary Sjögren's disease. 2026 (n=725).
5. Maciel G, et al. Prevalence of primary Sjögren's syndrome in a US population-based cohort. Arthritis Care Res. 2017;69(10):1612-1616.
6. Qin B, et al. Epidemiology of primary Sjögren's syndrome: a systematic review and meta-analysis. Ann Rheum Dis. 2015;74(11):1983-1989.
7. Ramos-Casals M, et al. EULAR recommendations for the management of Sjögren's syndrome with topical and systemic therapies. Ann Rheum Dis. 2020;79(1):3-18.
8. Stergiou IE, Poulaki A, Voulgarelis M. Pathogenetic mechanisms implicated in Sjögren's syndrome lymphomagenesis: a review of the literature. J Clin Med. 2020;9(12):3794.

Contact Service d'Immunologie Médicale, CHU Béni Messous, Alger — Faculté de Pharmacie, Université des Sciences de la Santé.

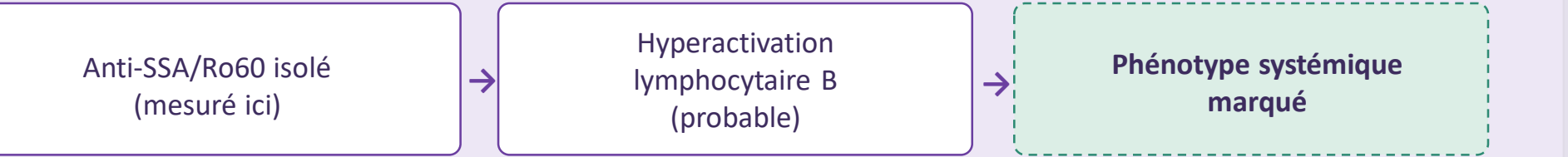
4 Discussion

■ FR+/anti-CCP– : au-delà de la PR

Dans la PR authentique, la co-positivité FR/anti-CCP est la règle. Un FR isolé sans anti-CCP doit élargir le spectre différentiel plutôt que confirmer d'emblée une PR. L'anti-CCP reste d'ailleurs rare dans le SSp (~5-10% des patients) et n'est pas retenu comme critère diagnostique ; quand il est présent, il est plutôt corrélé à une synovite non érosive (OR = 7,6 ; p = 0,01) qu'à une authentique PR (Atzeni et al., 2008). Sa négativité ici, malgré un tableau articulaire franc, oriente donc logiquement vers un mécanisme non citrulliné.

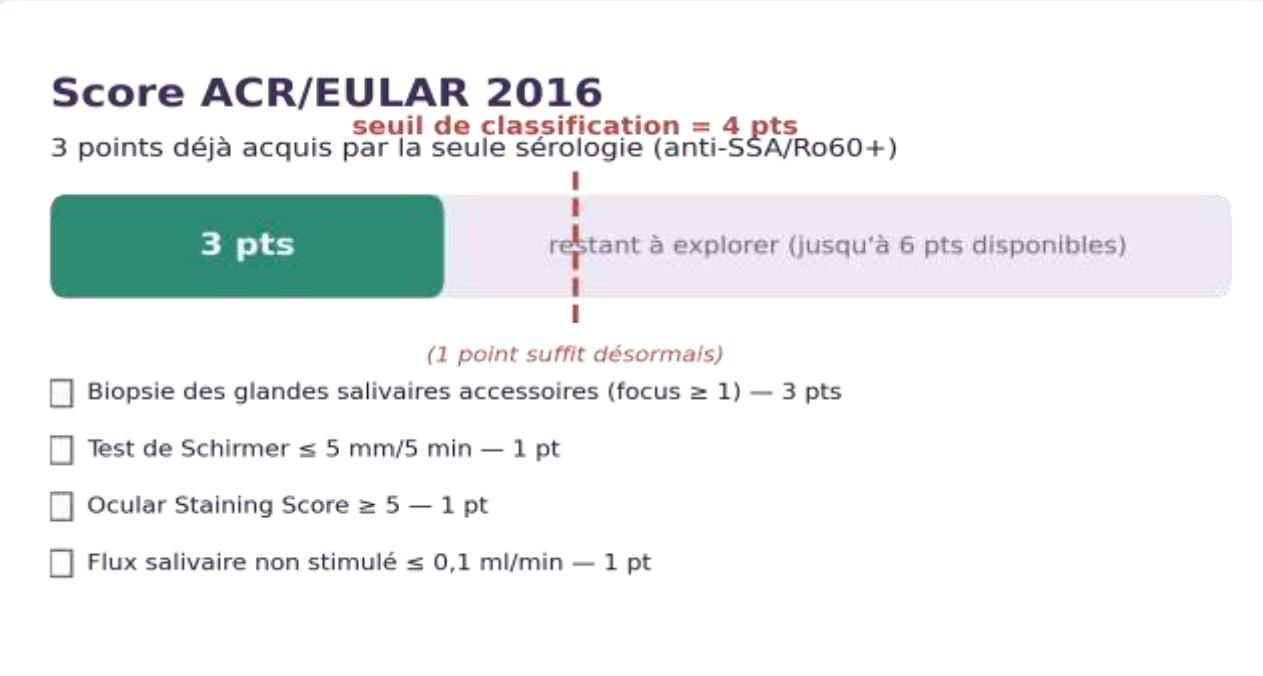
■ Anti-SSA/Ro60 : de la sérologie à la biologie

L'intensité exceptionnelle de l'anti-SSA/Ro60 (20 fois le seuil) évoque une hyperactivation lymphocytaire B polyclonale, signature distincte de la réponse citrullinée propre à la PR. (Bettacchioli et al., 2024 ; Armağan et al., 2022).



■ Pourquoi le FR et les AAN ont été exclus des critères 2016

Les critères ACR/EULAR 2016 reposent sur 5 items pondérés (anti-SSA/Ro60+ et focus score ≥1 : 3 points chacun ; Schirmer, flux salivaire : 1 point chacun) score ≥4 requis. Le FR et les AAN, jugés trop peu spécifiques, en ont été délibérément exclus (Shiboski et al., 2017). Dans ce cas, seule la sérologie anti-SSA apporte déjà 3 des 4 points nécessaires un bilan sicca ciblé (Schirmer, biopsie des glandes salivaires accessoires) suffirait à achever la classification.



■ Prise en charge et surveillance

Pour l'atteinte articulaire, les recommandations EULAR proposent l'hydroxychloroquine (200 mg/j) en première intention, associée si besoin à une corticothérapie à faible dose ou des AINS de courte durée. Le suivi doit aussi surveiller les signes prédictifs de lymphome propres au SSp,parotidomégalie persistante, purpura, adénopathies, cryoglobulinémie, hypocomplémentémie (C4 bas) d'autant plus qu'un titre élevé d'anti-SSA/Ro60 signe une forte activité B.

■ Perspectives & limites

Observation isolée, sans recul thérapeutique ni suivi à ce stade. Le dosage de l'anti-Ro52 et la réalisation du bilan sicca complet restent à programmer pour achever la classification et affiner le pronostic.

■ Synthèse de la littérature

Étude	n	Principal résultat
Atzeni et al., 2008	141	Anti-CCP associé à synovite non érosive (OR 7,6 ; p=0,01), présent chez 9,9% des pSS
Vallbracht et al., 2004	—	20-30% des PR sont FR+/anti-CCP– : le FR seul est insuffisant
Bettacchioli et al., 2024	146	Double positivité Ro52+/Ro60+ → activation voie IFN, sévérité accrue
Armağan et al., 2022	—	Double positivité Ro52/Ro60 → hyperactivité B, cible essais cliniques
Cohorte pSjD, 2026	725	Anti-Ro52 = marqueur de sévérité ; double positivité = atteinte multi-organe
Shiboski et al., 2017	—	Critères ACR/EULAR 2016 ; FR et AAN exclus (manque de spécificité)
Ramos-Casals et al., 2020	—	Recommandations EULAR : HCQ 200mg/j en 1re intention pour l'atteinte articulaire du SSp
Stergiou et al., 2020	—	Facteurs prédictifs de lymphome dans le SSp : parotidomégalie, cryoglobulinémie, C4 bas

En pratique : devant une polyarthrite FR+/anti-CCP–, demander systématiquement un bilan ENA (anti-SSA/Ro60, anti-SSB) avant de conclure à une PR séronégative — une positivité massive doit faire compléter le bilan sicca et instaurer une surveillance dédiée (signes de lymphome, hydroxychloroquine en 1re intention).